



GUIA PARA PACIENTES

Mão dormente à noite: síndrome do túnel do carpo

o que costuma ajudar e quando procurar o médico

Por que a mão formiga de madrugada, o que você pode fazer em casa e quais sinais pedem avaliação logo.



**DR. ROBERTO
RODRIGUES**
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
CIRURGIA DO JOELHO

CRM-CE 10806 · RQE 12256 · TEOT 17765 · @robertorodriguesmd

Material educativo. Não substitui consulta médica.

Palavra-chave no Instagram: **PUNHO**

Para quem é:

Para quem acorda à noite com a mão dormente ou formigando, principalmente no polegar, no indicador e no dedo médio, e precisa sacudir a mão para ela "voltar", **sem nenhum sinal de alerta da próxima página.**

Para quem NÃO é:

- Quem tem algum sinal de alerta da Página 3.
- Quem já sente **perda de força** na mão ou nota a base do polegar "murcha": isso pede avaliação, e não só medidas caseiras.
- Quem operou o punho recentemente: siga a orientação da sua equipe.
- Gestantes: as medidas deste guia são simples, mas converse antes com quem acompanha o seu pré-natal (opinião clínica).

O que você vai precisar:

- Uma tala de punho que deixe o punho **reto** (Página 6).
- Uma caneta para o rastreador da Página 7.

Regra de ouro:

Formigamento que **melhora** com as medidas: siga em frente.
Dormência que fica **constante**, ou mão que **perde força**: procure avaliação.
Os sinais completos estão na Página 3.

A maioria dos casos de mão dormente não é grave. Mas existe uma minoria que é, e ela tem sinais. **Leia esta página antes de qualquer outra.**

Ligue 192 (SAMU) ou vá ao pronto-socorro AGORA se:

- A dormência ou a fraqueza começou **de repente**, em **um lado do corpo** (rosto, braço ou perna), ou veio com **fala enrolada, confusão, alteração da visão, tontura, desequilíbrio ou dor de cabeça súbita e forte**. Pode ser **AVC**, e cada minuto conta [15].

Procure atendimento HOJE se:

- A dormência começou depois de **queda ou trauma no punho**, principalmente com inchaço, deformidade ou dor forte. É preciso afastar fratura e compressão aguda do nervo (opinião clínica).

Procure avaliação em poucos dias se:

- A mão está **perdendo força**: deixa cair objetos, tem dificuldade para abotoar ou fazer pinça [2].
- A **base do polegar está "murchando"** (atrofia), um sinal de doença mais avançada [2].
- A dormência ficou **constante**, de dia e de noite (opinião clínica).
- Os sintomas estão **nas duas mãos** e vêm com **desequilíbrio, dificuldade para andar, pernas dormentes ou perda de habilidade fina nas mãos**. Esse conjunto pode vir do pescoço, por compressão da medula, e não do punho (opinião clínica).

Observação honesta: o túnel do carpo pode, sim, afetar as duas mãos. O alerta é a combinação com os outros sinais.

Um túnel estreito no punho

Na frente do punho há um "túnel" formado pelos ossos e, por cima, por um ligamento firme. Por ele passam os tendões que dobram os dedos e o **nervo mediano**, que dá sensibilidade ao polegar, ao indicador, ao dedo médio e a parte do anelar. Quando a pressão dentro do túnel sobe, o nervo sofre. É a compressão de nervo mais comum que existe [1].

Os sintomas típicos

- Formigamento e dormência nesses dedos, que costumam **atrapalhar o sono** [4].
- Alívio ao **sacudir a mão**.
- Piora ao segurar algo por muito tempo, como o celular ou o volante (opinião clínica).
- Nos casos avançados: fraqueza e atrofia da base do polegar [2].

Quem tem mais risco

- **Gestação:** é comum. Muitas melhoram depois do parto, mas, numa revisão, mais da metade ainda tinha sintomas 1 ano depois [14].
- **Diabetes** (tipo 1 e tipo 2): chance cerca de 1,7 vez maior [11].
- **Hipotireoidismo:** associação modesta [12].
- **Trabalho com vibração, força e repetição** das mãos [13].

E o computador? Para a diretriz americana mais recente, não há evidência confiável de que digitar cause o problema [4].

Formigamento na mão nem sempre nasce no punho. O nervo pode ser apertado no caminho, principalmente na **coluna cervical** (o pescoço). Algumas pistas ajudam, mas **nenhuma substitui o exame** (opinião clínica):

	Mais a favor do punho	Mais a favor do pescoço
Onde formiga	Polegar, indicador e médio	Pode pegar o braço todo ou outros dedos
Dor no pescoço	Geralmente não	Frequente, às vezes descendo pelo braço
O que piora	Noite, punho dobrado, segurar objetos	Mexer ou inclinar o pescoço
O que alivia	Sacudir a mão	Mudar a posição do pescoço

As duas coisas podem existir na mesma pessoa. Por isso, o exame do pescoço faz parte da consulta (opinião clínica).

E a eletroneuromiografia?

É o exame que mede a condução elétrica dos nervos. Nos casos típicos, o diagnóstico pode ser feito pela história e pelo exame físico: a diretriz da Academia Americana de Cirurgiões Ortopédicos (AAOS, 2024) aceita um escore clínico (o CTS-6) no lugar do exame de rotina [4].

A eletroneuromiografia é útil para **confirmar casos atípicos, afastar outras causas e medir a gravidade** antes de uma cirurgia. Exame alterado ajuda a confirmar; exame normal não exclui totalmente [2].

A ressonância **não** é recomendada para diagnosticar o túnel do carpo [4].

Para casos leves a moderados, sem sinal de alerta [2]. Nenhuma medida é garantia.

Medida 1 — Tala noturna com o punho reto

Como fazer: à noite, use uma tala que deixe o punho **reto**, na linha do antebraço, com os dedos livres. Usar só à noite funciona tanto quanto usar o dia todo [2].

Sensação correta: punho firme e reto, dedos soltos, sem dormência nova.

Erro comum: tala que inclina o punho para cima, ou apertada demais. Num estudo, o punho reto aliviou mais que o punho inclinado 20° para cima [6].

Com honestidade: a revisão Cochrane de 2023 achou benefício pequeno e incerto, mas considera a tala razoável para quem não quer injeção nem cirurgia [5].

Medida 2 — Deslizamento do nervo

Como fazer: devagar, parando 3 a 5 segundos em cada posição: (1) mão fechada, punho reto; (2) dedos abertos e juntos; (3) punho e dedos para trás; (4) polegar afastado; (5) palma virada para cima. Repita 5 vezes, 2 vezes ao dia.

Sensação correta: leve estiramento, sem aumentar o formigamento.

Erro comum: forçar até formigar.

Com honestidade: a evidência é limitada e de baixa qualidade [7], e a AAOS (2024) não viu melhora a longo prazo com exercícios [4]. A sequência e as repetições são opinião clínica.

Semanas 1 e 2 — Começar

- Tala com o punho reto **todas as noites**.
- Deslizamento do nervo 2 vezes ao dia, se não piorar o formigamento.
- Evite dormir com o punho dobrado ou com a mão embaixo do travesseiro.

Semanas 3 a 6 — Manter e observar

- Continue a tala à noite.
- Faça pausas curtas nas tarefas com força, movimento repetido ou ferramenta que vibra.
- Preencha o rastreador uma vez por semana.

Prazos, posição de dormir e pausas são orientação prática (opinião clínica), não protocolo testado. Num estudo, o alívio com a tala costumava aparecer nas 2 primeiras semanas e mudava pouco até 2 meses [6].

Rastreador

	Noites em que acordou com a mão dormente (0–7)	Formigamento de dia (0–10)	Noites com a tala (0–7)	Deixou cair objetos? (S/N)
Semana 1				
Semana 2				
Semana 3				
Semana 4				
Semana 5				
Semana 6				

0 = nada · 10 = o pior que você imagina.

Leve esta tabela para a consulta. Ela mostra a tendência, e não só a pior noite.

Este guia não indica remédio, injeção nem dose. Isso depende da sua saúde e dos remédios que você já usa, e é decidido na consulta.

Remédios comuns

Analgésicos e anti-inflamatórios comuns **não mostraram benefício** no túnel do carpo [2]. A AAOS (2024) também não viu vantagem sobre o placebo do anti-inflamatório por via oral, de suplementos, de diuréticos nem de remédios para dor de nervo [4].

Infiltração com corticoide

- Uma revisão Cochrane (2023) mostrou **melhora dos sintomas em até 3 meses**, com benefício que pode durar até cerca de 6 meses, e leve redução da necessidade de cirurgia em 1 ano, nos casos leves e moderados [8].
- A AAOS (2024), com evidência forte: **não traz melhora a longo prazo** [4].
- Na prática: alívio temporário, útil em casos selecionados. Não desfaz a compressão (opinião clínica).

E o PRP?

A AAOS (2024), com evidência forte, concluiu que a injeção de PRP (plasma rico em plaquetas) **não traz benefício a longo prazo** no túnel do carpo [4].

Não use o remédio de outra pessoa nem repita uma receita antiga sem falar com o seu médico.

O que é

A cirurgia abre o ligamento que forma o "teto" do túnel e alivia a pressão sobre o nervo. Pode ser feita por um corte pequeno na palma ou por vídeo (endoscopia), com resultados semelhantes relatados pelos pacientes, e pode ser feita só com anestesia local [4].

Quando ela entra na conversa

- **Perda de força ou de sensibilidade comprovada no exame**, ou atrofia da base do polegar: nos casos graves, a cirurgia deve ser oferecida [2].
- **Falha do tratamento sem cirurgia**, com sintomas que atrapalham o sono e a rotina. A diretriz da AAOS de 2016 encontrou benefício maior da cirurgia, aos 6 e aos 12 meses, do que com tala, anti-inflamatório ou terapia, e uma única infiltração [3].

Uma honestidade necessária

Uma revisão Cochrane de 2024 concluiu que, na média dos estudos, **a eficácia da cirurgia comparada ao tratamento sem cirurgia ainda é incerta**: mais pessoas melhoram com ela, mas a diferença nos sintomas foi pequena, e a decisão deve pesar benefícios e riscos [9]. Contra a infiltração, a comparação também é incerta [10].

Depois da cirurgia

A AAOS (2024) não recomenda tala nem fisioterapia supervisionada de rotina [4]. Nenhuma cirurgia tem resultado garantido.

1. Esperar a mão perder força para procurar ajuda.

A atrofia da base do polegar é um achado tardio [2]. Dormência que virou constante merece avaliação antes disso.

2. Usar a tala errada, ou só de dia.

O alvo é a noite, com o punho reto [2][6].

3. Achar que todo formigamento vem do punho.

O pescoço, o cotovelo e outras doenças dos nervos também dão formigamento na mão. Por isso o exame é completo (opinião clínica).

4. Tratar a infiltração como solução definitiva.

O alívio costuma ser temporário, e não há melhora a longo prazo [4][8].

5. Forçar alongamento ou exercício até formigar.

Exercício não mostrou melhora a longo prazo [4], e forçar um nervo irritado costuma piorar os sintomas (opinião clínica).

Bônus: gastar com pulseira magnética ou suplemento "para o nervo".

Nenhum dos dois se mostrou melhor que o placebo [4].

Procure avaliação se:

- O formigamento **não melhora de forma clara em cerca de 6 semanas** de tala e ajustes.
- Você acorda com a mão dormente **na maioria das noites**.
- A dormência ficou **constante**, ou a mão está **perdendo força** (Página 3).
- Você está grávida e os sintomas atrapalham o sono ou as tarefas.
- **A qualquer momento:** apareceu algum sinal da Página 3.

O prazo de 6 semanas é orientação prática de consultório, e não uma regra rígida.

Se quiser uma avaliação

A consulta começa por **história e exame físico**: sensibilidade de cada dedo, força do polegar, testes do punho e **exame do pescoço e do cotovelo**. Só depois se decide se é preciso eletroneuromiografia e qual é o tratamento. Quando há indicação de cirurgia, o encaminhamento é feito ao **cirurgião de mão**, o especialista nesse procedimento.

Agendamento: agendar.drrobertorodrigues.com

Instagram: @robertorodriguesmd

Atendimento em Fortaleza (CE).

Material educativo. Não substitui consulta médica. Nenhum tratamento tem resultado garantido. Cada caso precisa de avaliação individual.

1. Padua L, Coraci D, Erra C, Pazzaglia C, et al. **Carpal tunnel syndrome: clinical features, diagnosis, and management.** Lancet Neurol. 2016;15(12):1273-1284. doi:10.1016/S1474-4422(16)30231-9. PMID: 27751557.
2. Wipperman J, Penny ML. **Carpal Tunnel Syndrome: Rapid Evidence Review.** Am Fam Physician. 2024;110(1):52-57. PMID: 39028782.
3. Graham B, Peljovich AE, Afra R, Cho MS, et al. **The American Academy of Orthopaedic Surgeons Evidence-Based Clinical Practice Guideline on: Management of Carpal Tunnel Syndrome.** J Bone Joint Surg Am. 2016;98(20):1750-1754. doi:10.2106/JBJS.16.00719. PMID: 27869627.
4. American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS). **Management of Carpal Tunnel Syndrome: Evidence-Based Clinical Practice Guideline.** Publicada em 18/05/2024 (substitui a edição de 2016). Disponível em: <https://www.aaos.org/cts2cpg>. Resumo: Shapiro LM, Kamal R, Brault J, Chen K, et al. J Am Acad Orthop Surg. 2025;33(7):e356-e366. doi:10.5435/JAAOS-D-24-01179. PMID: 39637428.
5. Karjalainen TV, Lusa V, Page MJ, O'Connor D, et al. **Splinting for carpal tunnel syndrome.** Cochrane Database Syst Rev. 2023;2(2):CD010003. doi:10.1002/14651858.CD010003.pub2. PMID: 36848651.
6. Burke DT, Burke MM, Stewart GW, Cambré A. **Splinting for carpal tunnel syndrome: in search of the optimal angle.** Arch Phys Med Rehabil. 1994;75(11):1241-1244. doi:10.1016/0003-9993(94)90012-4. PMID: 7979936.
7. Page MJ, O'Connor D, Pitt V, Massy-Westropp N. **Exercise and mobilisation interventions for carpal tunnel syndrome.** Cochrane Database Syst Rev. 2012;(6):CD009899. doi:10.1002/14651858.CD009899. PMID: 22696387.
8. Ashworth NL, Bland JDP, Chapman KM, Tardif G, et al. **Local corticosteroid injection versus placebo for carpal tunnel syndrome.** Cochrane Database Syst Rev. 2023;2(2):CD015148. doi:10.1002/14651858.CD015148. PMID: 36722795.
9. Lusa V, Karjalainen TV, Pääkkönen M, Rajamäki TJ, et al. **Surgical versus non-surgical treatment for carpal tunnel syndrome.** Cochrane Database Syst Rev. 2024;1(1):CD001552. doi:10.1002/14651858.CD001552.pub3. PMID: 38189479.
10. Ashworth NL, Bland JD, Chapman KM, Tardif G, et al. **Local corticosteroid injection versus surgery for carpal tunnel syndrome.** Cochrane Database Syst Rev. 2024;8(8):CD015101. doi:10.1002/14651858.CD015101. PMID: 39206746.
11. Pourmemari MH, Shiri R. **Diabetes as a risk factor for carpal tunnel syndrome: a systematic review and meta-analysis.** Diabet Med. 2016;33(1):10-16. doi:10.1111/dme.12855. PMID: 26173490.
12. Shiri R. **Hypothyroidism and carpal tunnel syndrome: a meta-analysis.** Muscle Nerve. 2014;50(6):879-883. doi:10.1002/mus.24453. PMID: 25204641.
13. Barcenilla A, March LM, Chen JS, Sambrook PN. **Carpal tunnel syndrome and its relationship to occupation: a meta-analysis.** Rheumatology (Oxford). 2012;51(2):250-261. doi:10.1093/rheumatology/ker108. PMID: 21586523.
14. Padua L, Di Pasquale A, Pazzaglia C, Liotta GA, et al. **Systematic review of pregnancy-related carpal tunnel syndrome.** Muscle Nerve. 2010;42(5):697-702. doi:10.1002/mus.21910. PMID: 20976778.
15. Brasil. Ministério da Saúde. **AVC (Acidente Vascular Cerebral).** Saúde de A a Z. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/a/avc>. Acesso em 05/10/2026.

Material educativo. Não substitui consulta médica.

Dr. Roberto Rodrigues · CRM-CE 10806 · RQE 12256 · TEOT 17765

